

CAPÍTULO 9.7

Hemoglobinopatías

PERFIL EUNACOM 1.071.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemia Drepanocítica (Células Falsiformes / Sicklemia)

Definición

Hemoglobinopatía por mutación puntual de la cadena beta → **Hb S** que polimeriza en hipoxia → eritrocitos con forma de "hoz" (drepanocitos/esclasiformes).

Clínica — Triada

- **Anemia: Generalidades** | Anemia hemolítica crónica
- **Infecciones** (asplenia funcional → riesgo de bacterias encapsuladas: neumococo, Haemophilus)
- **Trombosis** (vaso-oclusión) → infartos en múltiples órganos:
 - - Priapismo isquémico
 - - IAM, AVE
 - - Infartos renales → IR
 - - **Osteoporosis** / necrosis avascular de cabeza femoral
 - - **Crisis dolorosas** vaso-oclusivas (las más frecuentes)

Diagnóstico

- **Frotis:** drepanocitos (células en forma de semiluna u "hoz")
- **Electroforesis de Hb / cromatografía:** Hb S (confirma diagnóstico)
- Análisis genético

Tratamiento

- **Hidroxiurea** → ↑ producción de Hb F → ↓ sicklemia → menos crisis
- Analgesia para crisis dolorosas
- Transfusiones en anemia severa
- Profilaxis con penicilina (por asplenia funcional, especialmente en niños)
- Vacunación intensiva (neumococo, meningococo, Haemophilus B)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 22 años de ascendencia afrodescendiente consulta por dolor óseo agudo e intenso en extremidades y tórax tras cuadro respiratorio viral. Al examen: subictericia escleral, palidez, dolor a la palpación de huesos largos. Hemograma muestra anemia con VCM normal y frotis sanguíneo con eritrocitos en forma de hoz o medialuna (drepanocitos)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Anemia de Células Falciformes (Drepanocitosis): mutación puntual en gen de globina beta (HbS). La desoxigenación causa polimerización de la HbS, deformando los hematíes en hoz y provocando oclusión microvascular e isquemia tisular (crisis vasooclusivas dolorosas). Manejo agudo: Hidratación EV energética + Oxigenoterapia + Analgesia con Opioides potentes (Morfina) + Tratamiento de infecciones desencadenantes. Prevención crónica: Hidroxiurea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las talasemias se diferencian de la ferropénica por isocitosis (IDE normal) y aumento del recuento de glóbulos rojos
- Alfa talasemia: desde el nacimiento. Beta talasemia: desde los 6 meses
- Diagnóstico de talasemia: electroforesis de hemoglobina o cromatografía
- Tratamiento de talasemia severa: transfusiones periódicas + quelantes de hierro si hay sobrecarga
- Anemia falciforme: tríada de anemia + infecciones + trombosis
- En el frotis se ven drepanocitos (células en forma de semiluna/hoz)
- Diagnóstico de drepanocitosis: hemoglobina S en electroforesis
- Tratamiento clave de la anemia falciforme: hidroxiurea

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HEMOGLOBINOPATÍAS)

PREGUNTA 1

Paciente con anemia crónica, episodios de priapismo y crisis de dolor óseo. En el frotis se observan células en forma de semiluna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Talasemia beta mayor
- B)** Anemia de células falciformes
- C)** Microesferocitosis hereditaria
- D)** Anemia hemolítica autoinmune
- E)** Mielodisplasia

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento farmacológico clave de la anemia de células falciformes?

- A)** Hierro oral
- B)** Eritropoyetina
- C)** Hidroxiurea
- D)** Corticoides
- E)** Quelantes de hierro

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes características del hemograma diferencia la talasemia de la anemia ferropénica?

- A)** VCM bajo en talasemia y normal en ferropénica
- B)** Anisocitosis en talasemia e isocitosis en ferropénica
- C)** Isocitosis con glóbulos rojos aumentados en talasemia
- D)** Trombocitosis reactiva en talasemia
- E)** Reticulocitos bajos en talasemia

RESUMEN: HEMOGLOBINOPATÍAS

Esta clase aborda las hemoglobinopatías: talasemias y anemia de células falciformes (drepanocítica). Las talasemias son anemias microcíticas crónicas que se diferencian de la ferropénica por isocitosis (IDE normal) y aumento del recuento de glóbulos rojos. La alfa talasemia se presenta desde el nacimiento, la beta talasemia desde los 6 meses. El diagnóstico de talasemia se confirma con electroforesis de hemoglobina o cromatografía. El tratamiento va desde observación en casos leves hasta transfusiones periódicas en graves, con quelantes de hierro si hay sobrecarga. La anemia de células falciformes se caracteriza por la tríada de anemia, infecciones y trombosis, con manifestaciones como priapismo isquémico, IAM, ACV, infartos renales y osteoporosis. El diagnóstico se hace con electroforesis (hemoglobina S) y en el frotis se ven drepanocitos en forma de semiluna. El tratamiento incluye hidroxiurea, manejo transfusional y evaluación de antiagregantes/antitrombóticos.